

PARTE IV — O PLANO

Nos dez capítulos anteriores, construímos duas coisas. Primeiro, o mapa: o que está matando as pessoas depois dos 40, como o corpo envelhece por dentro, quais números importam, o que as artérias e o metabolismo revelam. Depois, o método: os quatro pilares do AGIR — alimentação, atividade física e suplementação; gestão metabólica; integração corpo-mente; ritmo circadiano e repouso.

Mas mapa e método não bastam. Falta o gesto que esta parte do livro existe para provocar — o leitor sair do papel passivo de quem lê sobre prevenção e assumir o papel ativo de quem aplica. Os dois capítulos a seguir tratam dessa transição. O Capítulo 11 mostra como ler o próprio painel. O Capítulo 12 trata de como avaliar um profissional de medicina preventiva e o que perguntar na primeira consulta.

Capítulo 11

Seu Placar de Longevidade: Onde Você Está?

Cinco anos depois do infarto, Ricardo voltou ao consultório com uma pasta. Não era a pasta de exames de rotina — era a pasta dele, de cinco anos, com o histórico inteiro: cada lipidograma, cada PCR, cada vitamina D, cada CAC, cada MAPA. Tinha 57 anos. Estava bem. E queria, naquela consulta, fazer uma coisa diferente.

Sentou, abriu a pasta sobre a mesa, e disse: “Doutor, eu hoje quero fazer eu mesmo. O senhor me orienta, mas quero ler meus exames. Quero entender o que cada número diz e o que cada número manda eu fazer.”

Eu fiquei em silêncio por um instante. Não porque a pergunta fosse difícil — porque era exatamente a pergunta que eu queria que todos os meus pacientes fizessem em algum momento. A pergunta de quem deixou de ser paciente passivo e virou coautor do próprio plano. A pergunta de quem entendeu que medicina preventiva não é um serviço prestado por outra pessoa — é um trabalho contínuo que o médico facilita mas o paciente conduz.

Naquela consulta, passamos duas horas fazendo o que Ricardo pediu.

Por Que Autoavaliação, e Por Que Agora

Existe uma diferença entre saber e saber aplicar. O leitor que chegou até aqui já sabe que ApoB importa mais do que LDL, que insulina de jejum sobe antes da glicose, que CAC é um exame de cinco minutos, que regularidade do sono prediz mortalidade melhor do que duração, que a PCR persistentemente acima de 1,5 frequentemente aponta para o eixo HPA mesmo quando todos os outros pilares parecem em ordem. Sabe muita coisa. Mas saber não basta — porque, no consultório real, quem traduz tudo isso em decisão é o próprio paciente, com o médico como guia.

O paciente que chega à consulta com a pasta já organizada, sabendo o que quer perguntar, sabendo qual número subiu e qual número desceu desde a última visita, sabendo qual pilar precisa de atenção neste trimestre — esse paciente extrai da consulta dez vezes mais do que o paciente que apresenta exames frescos sem contexto e espera o médico ler para ele.

A ferramenta para isso é o que vou chamar daqui em diante de placar — uma forma estruturada de revisar o próprio painel a cada três meses, identificar os dois pontos que mais importam neste trimestre, e trabalhar exatamente esses dois. Não dez, não vinte. Dois.

Antes de detalhar o placar, vale fixar três princípios sem os quais ele vira pontuação ansiosa em vez de bússola.

O placar não é nota. Não existe “tirar dez” no placar. Existe “onde estou”, “onde quero estar”, “qual o caminho mais curto entre os dois”. A pessoa que tem três itens em zona ótima e sete em zona de alerta não está pior do que a pessoa que tem oito ótimos e dois em alerta — está em um momento diferente do trabalho. O placar não compara; ele orienta.

Hábitos e números conversam. Ao longo do livro, vimos pacientes em que a contradição entre hábito aparente e marcador real revelou o problema. André treinava dez horas por semana, comia sem ultraprocessados, e ainda assim tinha PCR de 2,1 e homocisteína de 14 — porque o treino estava mal estruturado e a suplementação que o vegetarianismo dele exigia nunca tinha sido prescrita. Fernanda comia “bem para os padrões brasileiros”, fazia exercício, e tinha insulina de 13 e fígado gorduroso. Quando hábito aparente e marcador real não conversam, é o marcador que está dizendo a verdade — e o hábito que precisa de revisão.

Ação concentrada vence ação dispersa. Tentar mudar dez coisas ao mesmo tempo é a forma mais previsível de não mudar nenhuma. Marcos, no Capítulo 7, mudou alimentação, treino, suplementação e sono em paralelo — mas com um plano que respeitava a ordem das prioridades clínicas, não dez frentes simultâneas competindo por atenção. Foi por isso que funcionou.

Com esses três princípios em mente, o resto do capítulo é a aplicação.

O Placar dos Quatro Pilares

A forma que uso no consultório organiza o placar como **quatro perguntas simples, uma por pilar do AGIR**. Cada pergunta resume tudo o que o leitor já viu nos capítulos anteriores e força um diagnóstico honesto da situação atual.

Pilar A — A pergunta da Alimentação, Atividade Física e Suplementação

Em uma frase: seu corpo está sendo construído ou está sendo desgastado pela rotina dos seus últimos seis meses?

A resposta está em três marcadores objetivos e três comportamentos. Os marcadores são os do Capítulo 4 que dependem mais do estilo de vida: PCR ultrasensível (alvo abaixo de 1,0 mg/L), insulina de jejum (alvo abaixo de 8 µIU/mL) e vitamina D (alvo entre 40 e 60 ng/mL). Os comportamentos são os do Capítulo 7: padrão alimentar consistente baseado em comida de verdade, treino estruturado nos quatro domínios complementares (zona 2, força progressiva, alta intensidade curta, mobilidade) e suplementação individualizada por biomarcador, não por modismo.

A leitura honesta deste pilar é a mais simples do placar. Se os três marcadores estão em zona ótima e os três comportamentos estão estabelecidos, este pilar está saudável. Se alguma das duas colunas está em alerta — marcador alterado ou comportamento ausente —, este é um lugar para concentrar atenção no próximo trimestre. Quando os dois lados estão em alerta simultâneo, o pilar A é provavelmente onde o leitor precisa começar, antes de qualquer outro.

Composição corporal entra como leitura complementar, e aqui vale a pena ser específico, porque a maioria das pessoas se pesa e ignora o que importa. O peso na balança não é dado clínico relevante. O que importa é a razão cintura/altura (acima de 0,55 sinaliza acúmulo abdominal de risco), a circunferência abdominal (acima de 90 cm em homens e 80 em mulheres pelos critérios para população latino-americana), o índice de massa muscular apendicular obtido por bioimpedância de qualidade ou DEXA (abaixo de 7,0 kg/m² em homens e 5,5 em mulheres sugere sarcopenia), e a força de preensão palmar medida com dinamômetro (abaixo de 30 kg em homens e 20 em mulheres acima dos 50 anos é sinal de fragilidade funcional precoce). Esses quatro números, juntos, contam mais sobre a relação entre o seu corpo e o seu plano do que qualquer balança.

Pilar G — A pergunta da Gestão Metabólica

Em uma frase: o que o seu painel ampliado está dizendo, e há quanto tempo você não o mediu?

O Capítulo 4 estabeleceu o que precisa estar nesse painel. O Capítulo 8 mostrou como ler hormônios, farmacologia e genômica como sistema integrado. A pergunta do placar G é direta: você tem, dos últimos doze meses, ApoB, PCR ultrasensível, HbA1c, insulina de jejum, perfil hormonal completo (testosterona total e livre com SHBG em homens; estradiol, progesterona e FSH conforme estágio reprodutivo em mulheres), TSH com T3 e T4 livres, cortisol matinal, IGF-1, vitamina D, B12, ferritina, homocisteína, e função renal com creatinina e microalbuminúria? E, dos exames feitos uma vez na vida, você já tem Lp(a), MTHFR e APOE?

Se a resposta for não para mais da metade dos itens, o pilar G é onde o trabalho começa — porque sem o painel você está agindo no escuro nos outros pilares também. Se a resposta for sim para a maioria, a pergunta seguinte é se as faixas-alvo do livro estão sendo aplicadas (a relação ApoB/ApoA1 abaixo de 0,6, a homocisteína abaixo de 8, o TSH na faixa funcional de 1,0 a 2,5, a testosterona livre acima de 9 pg/mL em homens, a Lp(a) em valor que define se a meta de ApoB precisa ser ainda mais agressiva) ou se você está se contentando com a faixa “normal” do laboratório, que é a média de uma população que inclui muita gente em formação de doença.

Imagem entra como complemento essencial. Se você tem entre 40 e 75 anos, com risco cardiovascular intermediário e sem CAC score medido, este é o exame de menos de dez minutos que pode mudar toda a estratégia de prevenção — exatamente como mudou para Marcos. Se há suspeita clínica de hipertensão mascarada, oscilação de pressão entre normal e elevada, ou pressão resistente, MAPA de 24 horas entra como complemento da consulta. Densitometria óssea entra a partir da menopausa nas mulheres e em homens com história sugestiva ou uso prolongado de medicamentos que afetem osso.

Pilar I — A pergunta da Integração Corpo-Mente

Em uma frase: quando seu corpo grita inflamação ou cortisol e os outros pilares estão razoavelmente endereçados, você está olhando para a dimensão psicológica?

Este foi o pilar que Ana, no Capítulo 9, descobriu por último — e que mudou tudo o que os outros pilares não tinham conseguido mover. Por isso o placar I tem uma estrutura específica: ele não é uma pergunta isolada, é uma pergunta que você faz quando uma combinação aparece.

A combinação clássica é PCR persistentemente acima de 1,5 mg/L e cortisol matinal acima de 20 µg/dL apesar de pilares A, G e R razoavelmente trabalhados. Quando esse padrão aparece, é hora de olhar para o que o corpo está dizendo do outro lado: como anda seu nível médio de estresse percebido nos últimos meses; como está a qualidade do seu sono em termos subjetivos (acorda descansado ou acorda já com o dia pesando); quantas pessoas você tem com quem pode contar em uma crise real e essas pessoas sabem disso; quando foi a última vez que conversou com profissional de saúde mental, mesmo

preventivamente; e se existe prática regular de regulação do sistema nervoso (respiração estruturada, MBSR, exercício físico, exposição à natureza) ou se essa parte está na lista do “um dia eu começo”.

A leitura honesta deste pilar costuma ser desconfortável — e essa é a função dele. A maioria dos pacientes que vejo com PCR resistente após meses de trabalho biológico cuidadoso descobre, na conversa, que a dimensão psicológica nunca foi formalmente endereçada. Reconhecer isso não é fraqueza. É placar funcionando.

Pilar R — A pergunta do Ritmo Circadiano e Repouso

Em uma frase: o solo em que os outros três pilares se sustentam está estável?

O Capítulo 10 estabeleceu por que esta é a pergunta certa. Sono não é um pilar como os outros — é o substrato. Quando o substrato cede, os outros três cedem com ele, mesmo que pareçam em ordem por meses ou anos. Foi o que regrediu silenciosamente em Paulo dos doze aos dezoito meses depois da primeira consulta, e foi o que se recuperou — e ultrapassou o pico anterior — quando a apneia foi finalmente identificada e tratada.

A leitura do pilar R combina três níveis. O primeiro é de hábito: você dorme e acorda em horários consistentes, com variação menor que sessenta minutos entre dias úteis e fim de semana? Tem exposição à luz solar nos primeiros sessenta minutos depois de acordar? Reduz luz de telas nas duas horas antes de dormir? Quarto fresco e escuro? Última refeição duas a três horas antes de deitar? Cafeína contida à primeira metade do dia?

O segundo é de marcador específico do sono: existe algum sinal de apneia obstrutiva — ronco persistente, pausas observadas pelo parceiro, fadiga matinal mesmo com oito horas na cama, pressão arterial resistente a tratamento, testosterona baixa inexplicada, fibrilação atrial nova, idas frequentes ao banheiro de madrugada? Se sim, polissonografia não é exame opcional. Se feita, o IAH deve ser inferior a 5; entre 5 e 15 é apneia leve, 15 a 30 moderada, acima de 30 grave.

O terceiro é o padrão da pressão arterial em MAPA de 24 horas, quando indicado: a pressão sistólica deve cair ao menos 10% durante o sono comparada à vigília. Padrão *non-dipper*, em que essa queda não acontece, é frequentemente a primeira pista clínica de apneia ou cronodisrupção que ainda não foi reconhecida.

Quando o pilar R está bem trabalhado, os outros pilares trabalham com mais efeito. Quando o pilar R está mal endereçado, qualquer ganho nos outros pilares tende a ser temporário.

A Regra dos Dois

Aqui é onde o placar deixa de ser checklist e vira plano.

A pergunta que o leitor deve se fazer ao terminar a leitura dos quatro pilares não é “em quantos itens estou em zona de alerta?”. É outra: **dos itens em zona de alerta, quais são os dois com maior potencial de mover trajetória nos próximos três meses?**

Dois. Não dez.

Marcos chegou ao consultório no Capítulo 5 com um painel inteiro em zona de alerta — CAC de 412 já era prevenção secundária funcional, ApoB de 82 ainda alto apesar da estatina em dose baixa, insulina de 11, PCR de 1,6, vitamina D de 28, padrão alimentar disperso, treino sem estrutura, e um sono que ele não sabia que era ruim (cinco horas e meia em média, com dois despertares por madrugada). Se eu tivesse entregado a ele uma lista de quinze coisas para mudar, três meses depois ele teria mudado nada. O que fizemos no Capítulo 7 foi o oposto: dois ataques principais. Ataque farmacológico no ApoB, com intensificação da estatina, adição de ezetimiba, e alvo abaixo de 60. Ataque comportamental nos três motores do pilar A (alimentação mediterrânea com janela alimentar, treino estruturado nos quatro domínios, correção específica de vitamina D e introdução de magnésio treonato para o sono). Oito meses depois, ApoB em 58, insulina em 6, PCR em 0,6, vitamina D em 52, ergometria com ganho de 1,8 MET, composição corporal transformada. O CAC de 412 não mudou — cálcio depositado não se dissolve. O que mudou foi a velocidade do processo daqui em diante.

Ana, no Capítulo 9, quando finalmente endereçamos o pilar I, seguiu a mesma lógica em outra direção. Tudo o que dependia de corpo biológico já tinha sido otimizado nos dezoito meses anteriores, e os ganhos estavam documentados — vitamina D, insulina, ApoB, homocisteína, todos em faixa ótima. O que faltava era uma frente nova: tratamento estruturado da dimensão psicológica, com psicoterapia cognitivo-comportamental como trilha principal e prática diária de regulação do sistema nervoso (MBSR e vinte minutos de mindfulness matinal) como trilha paralelo. O antidepressivo em dose baixa por seis meses entrou como decisão compartilhada com a psiquiatra, apoiando as duas frentes. Seis meses depois, a PCR caiu de 1,8 para 0,7 e o cortisol matinal de 22 para 14. O que mudou foi o pilar que estava faltando — e a lógica ali não foi acrescentar dez intervenções psicológicas ao mesmo tempo. Foi endereçar o pilar I com foco, enquanto os outros pilares já trabalhados continuaram trabalhados.

Paulo, no Capítulo 10, quando a apneia foi identificada, também começou com duas frentes: CPAP titulado e protocolo circadiano completo (regularidade rígida de horário, luz matinal, janela alimentar, redução de cafeína e álcool). Tudo o mais — alimentação, treino, suplementação — continuou como estava. Duas frentes no pilar que faltava recuperaram a trajetória inteira em seis meses e levaram a testosterona a 540 ng/dL, acima do pico anterior.

A mensagem é a mesma nos três casos: ação concentrada em dois pontos por trimestre é o

que produz movimento mensurável. Ação dispersa em dez frentes é o que produz frustração. Quando você revisita seu placar a cada três meses e identifica os dois pontos a trabalhar, anote em algum lugar (uma página de caderno serve, um arquivo de bloco de notas serve), defina como vai medir o resultado em três meses, e foque. Os outros pontos do placar continuam ali, esperando seu trimestre. Não somem.

Calibração por Década

A composição do placar muda de peso conforme a década, mesmo quando os itens permanecem os mesmos.

Dos 40 aos 49, o placar é principalmente uma ferramenta de **detecção precoce**. É a janela em que intervenção tem maior retorno e menor custo, porque os assassinos silenciosos do Capítulo 2 já estão operando mas a maioria deles ainda é reversível com trabalho consistente. Fernanda, no Capítulo 6, é o exemplo claro: aos 41 anos, com insulina de 13, esteatose, ApoB de 108 e vitamina D de 22, reverteu todos os marcadores em seis meses sem uma única prescrição farmacológica. Essa janela de reversibilidade é regra nesta década, não exceção. Os exames-âncora a garantir aqui: painel ampliado completo anual; ApoB e Lp(a); composição corporal por bioimpedância de qualidade ou DEXA; CAC entre 40 e 45 anos se houver risco intermediário ou história familiar de doença cardiovascular precoce; colonoscopia a partir dos 45 (recomendação atualizada pela ACS em 2018 e pela USPSTF em 2021); mamografia anual a partir dos 40 nas mulheres conforme prática brasileira; rastreamento básico de saúde mental.

Dos 50 aos 59, o placar passa a ser ferramenta de **ação máxima**. Aproximadamente metade das mortes cardiovasculares prematuras ocorre nesta faixa. O que se conserva aqui pode ser preservado pelas décadas seguintes; o que se perde aqui é mais difícil de recuperar. Marcos, com 57 anos no Capítulo 5, é o paciente-tipo desta década — quando o CAC de 412 forçou reconhecimento de que prevenção primária já não era a categoria certa, a estratégia inteira mudou. Aos itens da década anterior, acrescentam-se: CAC se ainda não feito; densitometria óssea (mulheres pós-menopausa rotineiramente; homens com história sugestiva); TC de tórax de baixa dose anualmente em adultos de 50 a 80 anos com carga tabágica de pelo menos 20 maços-ano que sejam fumantes atuais ou tenham parado há menos de 15 anos (recomendação USPSTF 2021); painel hormonal completo com atenção à transição menopáusica nas mulheres e à queda de testosterona nos homens; avaliação cognitiva baseline para comparação futura; fundoscopia a cada um a dois anos; ultrassonografia transvaginal conforme orientação ginecológica.

Dos 60 em diante, o placar muda de eixo: de prevenir doença, passa a **preservar função**. Todos os itens anteriores continuam aplicáveis, mas a ênfase específica desta década é na avaliação funcional — sentar e levantar da cadeira, velocidade de marcha, força de

preensão palmar com dinamômetro, todos com pontos de corte validados para idade. Composição corporal com atenção especial à sarcopenia: ASMI assume prioridade. Densitometria óssea regular, anual ou bianual, dependendo de T-score inicial e tratamento. Reavaliação cognitiva periódica. Controle rigoroso do sono, porque apneia é mais prevalente e mais frequentemente subdiagnosticada nesta faixa etária. Rastreamento de distúrbios de audição e visão, porque ambos impactam cognição e equilíbrio. Avaliação periódica de risco de quedas, com revisão da medicação em uso para retirar o que seja desnecessariamente sedativo ou hipotensor.

Os Sinais Que Não Esperam

Existe uma categoria de sintoma que tira o leitor do modo placar trimestral e o leva ao modo "ligar agora". Vale separar com clareza.

São cardiovasculares: dor torácica desencadeada por esforço ou emoção, dispneia de início recente aos esforços habituais, síncope (desmaio súbito), palpitações persistentes ou associadas a tontura, claudicação (dor muscular em panturrilhas que aparece ao caminhar e cede ao parar). Metabólicos: perda de peso não explicada (mais de 5% em seis meses sem dieta), sede e micção excessivas persistentes, fadiga profunda com alteração em exames glicêmicos. Neurológicos: perda súbita de função motora ou sensitiva, alterações abruptas de fala, assimetria facial nova, confusão mental de início agudo, perda de memória progressiva que preocupa você ou sua família. Renais e urinários: redução súbita do volume urinário, espuma persistente na urina, edema em membros inferiores que não melhora com elevação. Oncológicos: sangramento não explicado em qualquer território, nódulos novos que crescem, alterações cutâneas (regra ABCDE para lesões pigmentadas — assimetria, bordas irregulares, coloração heterogênea, diâmetro maior que 6 mm, evolução), sudorese noturna profusa sem causa óbvia, febre persistente. Saúde mental: ideação suicida, ataques de pânico recorrentes, depressão que não responde a estratégias iniciais, uso abusivo de substâncias.

Para todos esses, o placar não vale. Vale procurar avaliação especializada agora. A regra é simples e absoluta: se você está em dúvida sobre a gravidade de algum desses sinais, a dúvida em si já é a resposta.

O Essencial em 60 Segundos

O placar é a ferramenta de autoavaliação que organiza o que o livro entregou em uma forma que cabe na sua mão. Não é nota nem julgamento — é leitura honesta de onde você está em cada um dos quatro pilares do AGIR a cada três meses, com objetivo de identificar os

pontos em que ação concentrada produz movimento mensurável.

Hábitos e marcadores conversam: quando aparente bom hábito convive com marcador alterado, é o marcador que está dizendo a verdade — e o hábito que precisa de revisão. Foi a lição clínica de André no Capítulo 3 e de Fernanda no Capítulo 6.

A regra prática que organiza ação é a regra dos dois: a cada trimestre, escolha os dois itens em zona de alerta com maior potencial de mover trajetória — e foque exatamente neles. Foi assim que o tratamento de Marcos no Capítulo 7, de Ana no Capítulo 9 e de Paulo no Capítulo 10 funcionou. Ação concentrada vence ação dispersa.

A composição do placar muda de peso conforme a década: dos 40 aos 49 é detecção precoce na janela de máxima reversibilidade; dos 50 aos 59 é ação máxima na janela em que mais mortes precoces podem ser evitadas; dos 60 em diante é preservação funcional, com ênfase em força, mobilidade, composição corporal e cognição.

Existem sinais que não esperam o próximo placar — dor torácica nova aos esforços, síncope, déficits neurológicos súbitos, sangramento não explicado, alterações cutâneas pelo critério ABCDE, ideação suicida, entre outros. Para esses, a regra é simples: se você está em dúvida sobre a gravidade, a dúvida já é a resposta.

Quem chegou a este ponto do livro tem o vocabulário e o contexto para ler o próprio painel. O que falta é o hábito — visitar o placar a cada três meses, escolher dois pontos, e trabalhar exatamente esses dois.

O placar é a ferramenta. Mas ferramenta sem parceria clínica para os pontos que exigem decisão técnica — interpretação contextualizada de painel hormonal, ajuste de farmacologia guiada por biomarcador, conduta diante de imagem alterada — produz só metade do resultado possível. A pergunta seguinte, e última antes do epílogo, é como avaliar um profissional de medicina preventiva e o que perguntar na primeira consulta. É o tema do Capítulo 12.